

Etablissement

Médecin

PROTOCOLE MÉDICAL PRÉÉTABLI

Traumatisme crânien

Conduite à tenir après choc à la tête, chute avec impact crânien ou suspicion de traumatisme crânien.

Indications

- Choc direct ou indirect à la tête.
- Chute avec impact crânien observé ou suspecté.
- Résident retrouvé au sol avec doute sur traumatisme.

Vérifications préalables

- Ne pas mobiliser précipitamment ; sécuriser l'environnement.
- Évaluer conscience, orientation, douleur cervicale, plaie, vomissements.
- Rechercher anticoagulant/antiagrégant et heure du traumatisme.
- Prendre paramètres si cela ne retarde pas l'alerte.

Ne pas appliquer ce protocole

- Trouble de conscience, déficit neurologique, convulsion ou vomissements.
- Anticoagulant/antiagrégant avec choc crânien significatif.
- Douleur cervicale importante ou suspicion traumatisme rachidien.
- Traumatisme violent, chute non témoin ou état inhabituel.

Conduite à tenir

- Surveiller sans laisser seul jusqu'à avis si doute.
- Se conformer à la fiche « Surveillance d'un Traumatisme Crânien ».
- Soins simples si plaie superficielle et état rassurant.
- Prévenir IDE/médecin pour conduite et surveillance.
- Transmettre mécanisme, heure, traitements et signes observés.

Surveillance et traçabilité

- Tracer heure, mécanisme, examen neurologique sommaire et paramètres.
- Surveiller conscience, vomissements, céphalées, comportement, déficit.
- Noter appels, consignes reçues et évolution.

Alerte immédiate

- Appel médical rapide pour tout traumatisme crânien chez résident fragile ou anticoagulé.
- Appel 15 si trouble de conscience, déficit neurologique, convulsion, vomissements, céphalée intense ou traumatisme sévère.

Mention de sécurité

Un traumatisme crânien peut s'aggraver secondairement. Surveillance et traçabilité doivent être rigoureuses.

Fait à :

Le : / /

Signature :